1 Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention

Lernziele

Nach der Lektüre dieses Kapitels

- wissen Sie, welcher Unterschied im deutschsprachigen Raum zwischen Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention vorgenommen wird,
- können Sie die Inhalte und Grundhaltungen der Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention benennen,
- kennen Sie verschiedene Zugänge zur Gesundheitsförderung und können in diesem Zusammenhang den Mehrebenen- und Setting-Ansatz beschreiben,
- kennen Sie ein theoretisches Rahmenmodell zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention,
- sind Sie in der Lage, das Gesunde-Städte-Projekt zu charakterisieren,
- haben Sie die Notwendigkeit von Gesundheitsförderungsmaßnahmen reflektiert, die auf die Lebenswelt einer Zielgruppe zugeschnitten sind,
- sind Ihnen die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale von Präventionsmaßnahmen vertraut,
- haben Sie einen ersten Überblick über die gesetzliche Einbettung von Prävention und über das Präventionsgesetz erhalten,
- sind Ihnen Möglichkeiten und Schwierigkeiten bei der Erfassung der Kosten und der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen bekannt,
- kennen Sie Beispiele für die Anwendung und Evaluation von Präventionsprogrammen.

1.1 Gesundheitsförderung versus Krankheitsprävention – Zentrale Definitionen und Begriffsbestimmungen

Zentrale Gegenstandsbereiche der Gesundheitspsychologie sind der Erhalt und die Förderung von Gesundheit sowie die Verhütung von Störungen und Krankheiten (Schwarzer, 2002). Dies wird bereits im Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie" des Kurses 1 im Zusammenhang mit den Themen und Grundhaltungen der Gesundheitspsychologie erläutert. Einige der dort eher kurz behandelten Aspekte werden im Folgenden aufgegriffen und vertieft.

Die Gesundheitspsychologie geht dabei von dem umfassenden Gesundheitsverständnis der Weltgesundheitsorganisation (WHO; Grad, 2002) aus, demzufolge Gesundheit mehr ist als nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen, sondern ein Zustand völligen körperlichen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Die Konzipierung, theoretische Einbettung und Evaluierung von Interventionsprogrammen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention, durch die Gesundheit im Sinne dieses umfassenden Verständnisses gefördert oder wiederhergestellt wird, sind wichtige Anwendungsgebiete gesundheitspsychologischer Forschung und Anwendung.

Zwischen den Inhalten der Gesundheitsförderung und der Prävention von Krankheiten und gesundheitlichen Gefährdungen gibt es diverse Unterschiede, jedoch auch einige Überschneidungen. So sind in der Praxis die Grenzen zwischen Prävention und Gesundheitsförderung inklusive ihrer Ansatzpunkte und Prinzipien manchmal fließend, insbesondere in jenem Bereich der Prävention, der auf die Verhinderung der Entstehung von Krankheiten abzielt und daher vor allem bei (relativ) gesunden Menschen mit Verbesserungspotenzialen bezüglich ihres gesundheitsbezogenen Verhaltens ansetzt.

Eine Kontrastierung beider Begriffe ist sinnvoll, da im deutschen Sprachraum eine deutliche Abgrenzung der beiden Begriffe vorgenommen wird. Im angloamerikanischen Sprachraum

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

werden hingegen die Begriffe Gesundheitsförderung (engl.: health promotion) und Krankheitsprävention (engl.: disease prevention) in der Regel bedeutungsgleich verwendet.

Gemeinsames Ziel von Maßnahmen beziehungsweise Interventionen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention ist die Verbesserung und Erhaltung von Gesundheit auf individueller und kollektiver Ebene durch die Reduktion von Krankheitsrisiken sowie die Förderung gesundheitlicher Ressourcen. Die Unterschiede der beiden Zugangswege liegen in ihren grundlegenden Ansätzen, dem Krankheitsparadigma (siehe Kurs 1, Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie"), den Kernfragen und dem Gesundheits- und Krankheitsbegriff (siehe Tabelle 1.1).

Tabelle 1.1

Gesundheitsförderung und Prävention

Konzepte	Gesundheitsförderung	Prävention
Ansatz	**Salutogenese (Antonovsky)** Betonung von protektiven Faktoren/Ressourcen, Resilienz, Kohärenzgefühl und Selbstwirksamkeit	**Pathogenese** Identifizierung von Risikofaktoren, gesundheitsschädlichen Verhaltensweisen
Krankheitsmodell	biopsychosozial	biomedizinisch
Kernfrage	Was erhält Menschen gesund (trotz Belastungen)?	Was macht Menschen krank (Risikofaktoren)?
Gesundheits- und Krankheitsbegriff	Gesundheit und Krankheit befinden sich auf einem Kontinuum (kein Gegensatzpaar)	Krankheit ist ein regelwidriger Zustand, Diagnostik mit ICD-10 (bzw. ICD-11) der WHO

Anmerkung. Nach Schön, 2007, S. 100.

Während sich Gesundheitsförderung an der Dynamik der Entstehung von Gesundheit orientiert, ist Krankheitsprävention an der Dynamik der Entstehung von Krankheiten ausgerichtet. Dementsprechend ist das Wirkprinzip der Krankheitsprävention die Ausschaltung beziehungsweise das Zurückdrängen von Risikofaktoren, das der Gesundheitsförderung hingegen der Aufbau und die Stärkung von Schutzfaktoren und Ressourcen (Hurrelmann et al., 2024).

1.2 Gesundheitsförderung

Die übergeordnete Zielstellung der Gesundheitsförderung ist die Verbesserung von Gesundheit durch verschiedene Strategien und Interventionen. Diese umfassen sowohl die Vermittlung und Stärkung von Gesundheitskompetenzen als auch die Verbesserung von Umgebungsbedingungen (Hurrelmann et al., 2024). Zu dem letztgenannten Punkt zählt unter anderem der Abbau von (sozialen, gesellschaftlichen) Ungleichheiten, die gesundheitsbeeinträchtigend wirken können (Lampert et al., 2022; siehe auch Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping").

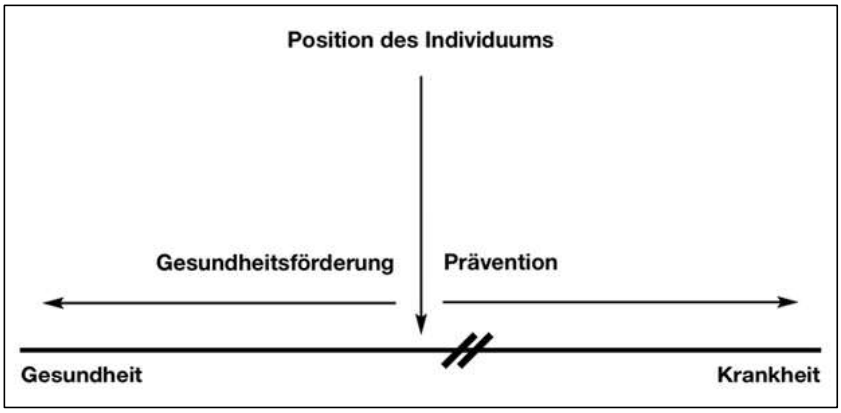
Die Gesundheitsförderung besitzt eine salutogenetische Grundhaltung. Das Konzept der Salutogenese, dessen zentrales Anliegen das Verständnis der Entstehungs- und Erhaltungsbedingungen von Gesundheit ist (siehe Kurs 1, Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie"), steht dem der Pathogenese (griech.: Pathos = Krankheit) gegenüber, die sich in erster Linie an krankmachenden Faktoren beziehungsweise Risikofaktoren orientiert.

Die salutogenetische Sichtweise interpretiert Gesundheit und Krankheit nicht als einander ausschließende Zustände, sondern als gedachte Endpunkte eines Gesundheits-Krankheits-Kontinuums. Der Gesundheitszustand einer Person kann als deren aktuelle Position auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum beschrieben werden (siehe Abbildung 1.1).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 1.1

Ziele von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention. Aus Becker, 1997, S. 519.



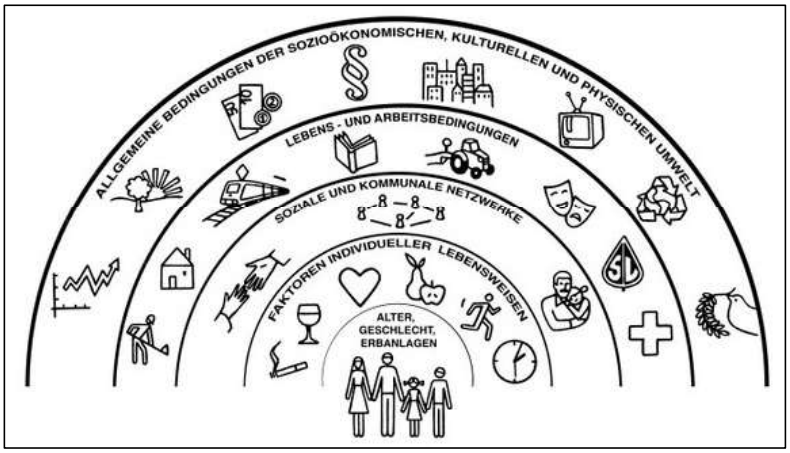
Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die ermittelte Position einer Person auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum nach links, also in Richtung des Endpunkts Gesundheit, zu verschieben (siehe Abbildung 1.1). Somit ist Gesundheit nach dem ressourcenorientierten beziehungsweise salutogenetischen Ansatz nach Antonovsky (1979, 1987) keine klar abgegrenzte Kategorie im Sinne von „gesund versus krank", sondern ein dynamischer Prozess. Diese Perspektive ist insbesondere im Kontext der Gesundheitsförderung für Menschen mit chronischen Erkrankungen und dauerhaften Behinderungen hilfreich, da nicht die Beeinträchtigung durch eine Krankheit oder Behinderung im Vordergrund steht, sondern die Förderung von Gesundheitskompetenzen, Unterstützung bei der gesellschaftlichen Teilhabe und die Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens sowie der gesundheitsbezogenen Lebensqualität fokussiert werden (siehe auch Kurs 2, Kapitel 7 „Patientenschulungen").

1.2.1 Zugänge in der Gesundheitsförderung

Die Determinanten, die im Zusammenhang mit dem Erhalt und der Förderung von Gesundheit bedeutsam sein können, sind vielfältig und müssen im Kontext der sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen eines Menschen betrachtet werden (siehe Abbildung 1.2). Dies entspricht der ökologisch-systemischen Sichtweise von Menschen und ihren Umwelten, die die Gesundheitspsychologie insgesamt einnimmt (siehe auch Kurs 1, Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie").

Abbildung 1.2

Gesundheitsdeterminanten. Verfügbar unter http://fgoe.org/sites/fgoe.org/files/2018-02/Determinanten_sw_0.jpg



Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Gesundheitsförderung ist ein komplexes individuelles, soziales und gesellschaftliches Anliegen, das die Verbesserung von gesundheitsrelevanten Lebensweisen und -bedingungen umfasst. Dementsprechend will Gesundheitsförderung nicht nur auf die Lebens- und Handlungsmöglichkeiten Einzelner einwirken und Menschen auf diesem Weg zur Verbesserung ihrer Gesundheit befähigen, sondern darüber hinaus ökonomische, soziale, ökologische und kulturelle Bedingungen verändern, die Gesundheit und Krankheit beeinflussen können (Kaba-Schönstein, 2017).

Dies verweist auf die gesundheitspolitische Relevanz der Gesundheitsförderung, die auch angesichts steigender Prävalenzraten von chronischen Erkrankungen in Form von Maßnahmen zur gesundheitsbezogenen „Hilfe zur Selbsthilfe" zunehmend an Bedeutung gewinnt (Rosenbrock & Kümpers, 2006). Ausdruck dieser Entwicklung sind beispielsweise die von Krankenkassen angebotenen Programme zur Förderung einer gesundheitsbewussten Lebensweise (z. B. Stressbewältigungstrainings, Nikotinentwöhnung und Kurse zur ausgewogenen Ernährung wie auch Programme zur Bewegungsförderung) sowie die Einführung von Bonusprogrammen durch Krankenkassen, mit denen gesundheitsbewusstes Verhalten, wie etwa regelmäßige sportliche Aktivität, finanziell gefördert wird. Ein globales Ziel ist die feste Verankerung von Gesundheitsförderung im direkten Lebensumfeld beziehungsweise im Alltag von Menschen. Damit verbunden ist die Stärkung von Eigeninitiative und Eigenverantwortung für eine nachhaltig gesundheitsbewusste Lebensweise und Einstellung (Altgeld, 2024).

Gesundheitsförderung im Sinne der Ottawa-Charta

Auf der ersten internationalen Konferenz zur Gesundheitsförderung wurde die „Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung" (World Health Organization, 1986) verabschiedet, in der Gesundheitsförderung folgendermaßen definiert wird:

> *„Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern beziehungsweise verändern können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung für Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor, sondern bei allen Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden hin."* (World Health Organization, 1986, S. 1)

Die Ottawa-Charta enthält somit zwei wesentliche Kerngedanken: Erstens ist die Gesundheitsförderung eine Aufgabe aller Politikbereiche und zweitens bildet die Stärkung der Kompetenzen, die es Individuen und Gruppen ermöglichen, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, die eigenen Stärken zu erkennen und Einfluss auf ihre Umwelt auszuüben, einen zentralen Ansatzpunkt hierfür (Altgeld, 2024). Die Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten und ein aktives, gesundheitsförderliches Handeln benötigen die Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Gesamtpolitik. In mehreren WHO-Folgekonferenzen wurden die Strategien und Handlungsfelder der Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung weiterentwickelt

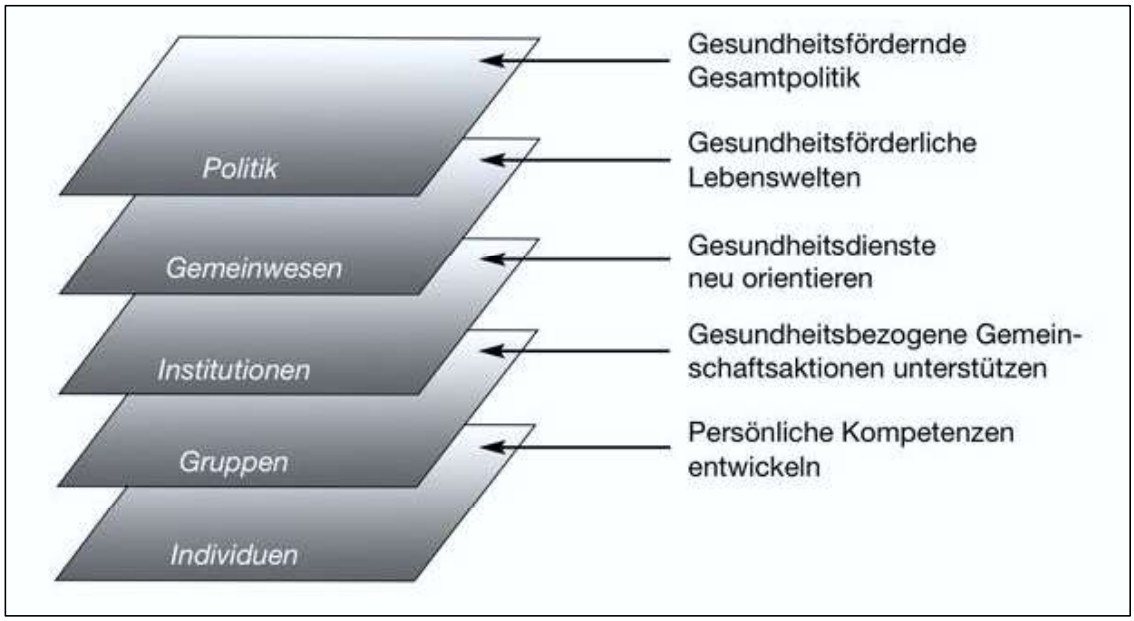
Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

und geschärft. Die auf diesen Konferenzen behandelten Schwerpunktthemen und die dort verabschiedeten Grundsatzdokumente können unter https://www.who.int/health-topics/health-promotion eingesehen werden.

Für gezielte Interventionen ist die Kenntnis salutogenetischer Dynamiken elementar (Altgeld, 2024). Nur so können durch die Verbesserung ökonomischer, kultureller, bildungsbezogener und hygienischer Bedingungen individuelle Fähigkeiten zur Lebensbewältigung gestärkt werden. In der Ottawa-Charta finden sich drei verschiedene Handlungsprinzipien einer „New Public Health": Sie umfassen die Kompetenzen „Interessen vertreten" (engl.: advocate), „befähigen und ermöglichen" (engl.: enable) und „vermitteln und vernetzen" (engl.: mediate) (World Health Organization, 1986). Darüber hinaus wurden fünf vorrangige Handlungsebenen für Gesundheitsförderung benannt: der sogenannte *Mehrebenen-Ansatz* (siehe Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3

Mehrebenen-Ansatz der Gesundheitsförderung. Aus Kaba-Schönstein, 2017



Eine gesundheitsförderliche Gesamtpolitik beschränkt sich nicht nur auf die Sicherung medizinischer und sozialer Versorgung, sondern eine Repräsentation der Gesundheit in allen Politikbereichen. Erst diese ermöglicht eine Sicherung gesundheitsförderlicher Lebenswelten. In Deutschland herrscht nach wie vor eine eher kurative, medizinische Betreuung vor. Entsprechend des Mehrebenen-Ansatzes sollte jedoch eine bessere Koordination zwischen dem Versorgungssystem und anderen gesellschaftlichen Bereichen – beispielsweise durch gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen in Nachbarschaften und Gemeinden – erfolgen. Die Möglichkeit zur Entwicklung persönlicher gesundheitsbezogener Kompetenzen ist umso eher gegeben, je umfassender auf den übergeordneten Ebenen gesundheitsfördernde Bedingungen realisiert sind. Video 1.1 veranschaulicht die Handlungsstrategien und Ebenen der Gesundheitsförderung, die in der Ottawa-Charta festgehalten wurden. Die konkrete Anordnung der ansonsten identischen Ebenen des Mehrebenen-Ansatzes unterscheidet sich in verschiedenen Publikationen und Darstellungsformen geringfügig; dementsprechend finden sich marginale Unterschiede zwischen der Darstellung in Abbildung 1.3 und Video 1.1, die jedoch keine inhaltliche Bedeutung haben.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Video 1.1. An introduction to Health Promotion and the Ottawa-Charter (Appuhamiy & Clark). Verfügbar unter https://youtu.be/G2quVLcJVBk

Der Setting-Ansatz in der Gesundheitsförderung

Eine weitere Kernstrategie der Gesundheitsförderung ist der Setting-Ansatz, der Gesundheitsförderung auf die Lebensbereiche, Systeme und Organisationen ausrichtet, in denen Menschen einen großen Teil ihrer Lebenszeit verbringen und die mit ihrem sozialen Gefüge die Gesundheit der Einzelnen beeinflussen. Er ist daher ein Ansatz, der ergänzend zum Mehrebenen-Ansatz wirksam wird, da alle fünf Ebenen der Gesundheitsförderung in Bezug auf Settings relevant sein können. Settings (im Deutschen auch: Lebenswelten) sind etablierte soziale Systeme (z. B. Kindertagesstätten, Betriebe, Gemeinden), von denen bekannt ist oder angenommen wird, dass sie einen Einfluss auf die Gesundheit haben und die durch gesundheitsfördernde Maßnahmen gestaltet werden können (Dadaczynski, 2022).

Gesundheitsförderung nach dem Setting-Ansatz der Ottawa-Charta der World Health Organization (1986) umfasst neben Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit durch Vermittlung und Stärkung von Gesundheitskompetenzen ebenso eine Veränderung der Lebensverhältnisse von Menschen und den Abbau sozialer Ungleichheiten (Lampert et al., 2022). Gesundheitsförderung zielt also, wie oben bereits beschrieben, nicht nur darauf ab, Menschen im Sinne des Salutogenese-Konzepts nach Antonovsky (1979, 1987)) zu befähigen, mehr Kontrolle über die ihre Gesundheit beeinflussenden Faktoren zu erlangen, sondern auch auf die Reduktion bestehender sozialer Benachteiligungen in der Gesundheits- und Lebenserwartung bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen.

Eine wesentliche Grundidee des Setting-Ansatzes besteht daher darin, Gesundheit nicht als abstraktes Ziel zu definieren, sondern als etwas, was im Alltag hergestellt und aufrechterhalten werden muss. Daher muss Gesundheitsförderung in den Alltag der Menschen integriert werden. Mithilfe des Setting-Ansatzes können Ziele und Zielgruppen genau definiert und Strategien daraufhin genau auf diese Rahmenbedingungen zugeschnitten werden (Whitelaw et al., 2001).

Die „Schaffung gesundheitsfördernder Lebenswelten“ als eine der fünf zentralen Handlungsebenen sowie das „Vermitteln und Vernetzen“ als eine der drei zentralen Handlungsstrategien der Gesundheitsförderung heben die Bedeutung des Setting-Ansatzes für die Gesundheitsförderung hervor. Die internationalen Folgekonferenzen der WHO zur Gesundheitsförderung, die oben erwähnt werden, haben den Setting-Ansatz als Kernstrategie der Gesundheitsförderung in ihr Programm aufgenommen (siehe Abbildung 1.4) und in seiner Anwendung bestätigt und fortgeschrieben.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Abbildung 1.4

Entwicklung des Setting-Ansatzes der Gesundheitsförderung im Rahmen der internationalen WHO-Konferenzen zur Gesundheitsförderung. Verfügbar unter https://www.tk.de/resource/blob/2026636/f55b213879b922ba0e3755bd9b380429/gesundheitsfoerderung-an-hochschulen-data.pdf



Anmerkung. Informationen zur 9. WHO-Konferenz in Shanghai (2016) sind verfügbar unter https://www.who.int/publications/i/item/promoting-health-in-the-sdgs. Informationen zur 10. WHO-Konferenz in Genf (2021) sind verfügbar unter https://www.who.int/news/item/15-12-2021-10th-global-conference-on-health-promotion-charters-a-path-for-creating-well-being-societies

Das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell

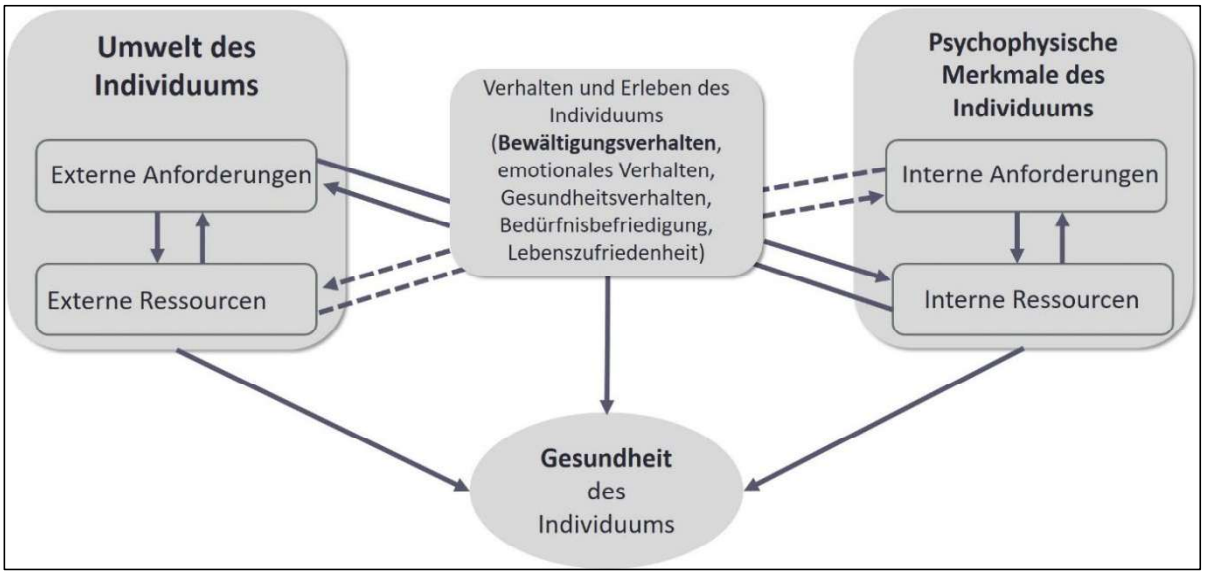
Das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell (SAR-Modell; Becker, 2006) stellt den Versuch dar, die in Abbildung 1.3 dargestellten Ebenen miteinander zu verbinden und zu integrieren. Es basiert auf dem transaktionalen Stressmodell nach Lazarus (Lazarus & Folkman, 1984, siehe Kurs 1, Kapitel 7 „Stress und Stressbewältigung") sowie dem salutogenetischen

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Ansatz (Antonovsky, 1979, 1987) und berücksichtigt bedürfnistheoretische, systemische und ökologische Perspektiven und Ansätze. Im SAR-Modell werden Gesundheit und Krankheit als Resultat von Anpassungs- und Regulationsprozessen zwischen einer Person und ihrer Umwelt konzipiert. Sowohl die Umwelt als auch die Person werden als komplexe, hierarchisch strukturierte Systeme aufgefasst. Zur Bewahrung oder Förderung der Gesundheit ist es erforderlich, dass es der Person gelingt, externe und interne Anforderungen mit Hilfe externer und interner Ressourcen zu bewältigen (Becker, 2006; siehe Abbildung 1.5).

Abbildung 1.5

Das systemische Anforderungs-Ressourcen-Modell. Nach Blümel, 2024



Anforderungen sind im SAR-Modell Bedingungen, mit denen sich eine Person auseinandersetzen muss. Externe Anforderungen entstammen dabei aus der Umwelt, wie beispielsweise berufliche oder private Anforderungen von Personen oder Bedingungen (z. B. der Wunsch der Partnerin/ des Partners nach gemeinsamen Aktivitäten). Interne Anforderungen hingegen resultieren aus individuellen Bedürfnissen, Zielen und Wertevorstellungen. Neben körperlichen Grundbedürfnissen sind das beispielsweise Erkunden der Umwelt und des Selbst, Selbstverwirklichung, Orientierung, Sicherheit, Bindung und Achtung.

Diesen Anforderungen stehen interne und externe Ressourcen gegenüber. Analog zu den Anforderungen entstammen auch externe Ressourcen der Umwelt. Diese können sich auf unterschiedliche Lebenswelten beziehen, auf die sich die Bedürfnisse des Individuums richten (z. B. liebevolle Beziehungen, sinnvolle Arbeitsaufgaben). Interne Ressourcen sind die zur Verfügung stehenden Handlungsmöglichkeiten und Eigenschaften (z. B. Fähigkeiten, Kompetenzen, Selbstwirksamkeitserwartungen, Persönlichkeitseigenschaften), sowie körperliche Voraussetzungen (z. B. physische Fitness, Gesundheitszustand).

Im günstigen Fall werden Anforderungen durch die Nutzung oder den Austausch von Ressourcen bewältigt (siehe Abbildung 1.5). So reagiert beispielsweise eine Person auf eine externe Anforderung (z. B. Zusatzarbeit durch die Krankheit einer Kollegin) mit der Aktivierung interner und/oder externer Ressourcen (z. B. Suche nach sozialer Unterstützung). Umgekehrt kann die soziale Umwelt externe Ressourcen bereitstellen, wenn die internen Anforderungen einer Person (z. B. Bedürfnis nach Sicherheit und körperlicher Unversehrtheit) wahrgenommen beziehungsweise kommuniziert werden. Eine solche externe Ressource kann beispielweise der Zugang zu Leistungen des Gesundheitssystems sein. Gesundheitsbeeinträchtigungen werden im

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

systemischen Anforderungs-Ressourcen-Modell als Folge unangemessener Anforderungen und/oder fehlender Ressourcen beschrieben. Ein guter Gesundheitszustand hingegen resultiert aus einem Gleichgewicht zwischen Anforderungen und Ressourcen (Becker, 2006).

Das SAR-Modell bietet einen theoretischen Rahmen für die Begründung und Integration von Ansätzen zur Gesundheitsförderung. Folgende Ansatzpunkte für Gesundheitsförderung lassen sich aus dem Modell ableiten: Anpassung externer oder interner Anforderungen, Bereitstellung externer Ressourcen, Stärkung und Vergrößerung interner Ressourcen (Blümel, 2024; Reimann & Hammelstein, 2006). Bei der Anpassung externer Anforderungen werden die äußeren Bedingungen an die individuellen Voraussetzungen und Besonderheiten der Person angepasst. Beispiele hierfür wären erweiterte Gestaltungs- oder Kontrollmöglichkeiten am Arbeitsplatz, oder die Verbesserung sozialer und ökologischer Umweltbedingungen (z. B. geregelte Pausenzeiten, ergonomische Arbeitsplatzgestaltung). Die Anpassung interner Anforderungen fokussiert sich auf die Vermeidung psychischer und physischer Unter- oder Überforderung in verschiedenen Lebensbereichen (z. B. intellektuelle Unter-/Überforderung am Arbeitsplatz, physische Unter-/Überforderung durch Bewegungsmangel oder Substanzmissbrauch), sowie die Befriedigung von Bedürfnissen (z. B. durch Entspannungs- und Genussübungen, oder Erholung). Unter der Bereitstellung externer Ressourcen können Aspekte wie eine saubere Umwelt, funktionierende gesellschaftliche Systeme (Bildungs-, Gesundheits-, politisches, kulturelles Wertesystem), zufriedenstellende Wohnbedingungen, Aufbau, Pflege und Nutzung sozialer Unterstützungssysteme, Bereitstellung eines ausgewogenen Nahrungsangebotes und von Gesundheitsaufklärung und -trainings, sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Bildungsmöglichkeiten verstanden werden. Die Stärkung und Vergrößerung interner Ressourcen kann beispielsweise durch die Verbesserung der körperlichen Fitness, der psychischen Gesundheit, sozialer und gesundheitsbezogener Kompetenzen, Stressbewältigungskompetenzen und Vertiefung schulischen, beruflichen oder gesundheitsbezogenen Wissens erfolgen (Blümel, 2024; Reimann & Hammelstein, 2006).

1.2.2 Beispiele für Ansatzpunkte und Strategien gesundheitsfördernder Maßnahmen

Gesundheitsfördernde Maßnahmen können sich dahingehend unterscheiden, wie umfangreich, aber auch wie innovativ ihre Ansätze sind. Die folgenden beiden Beispiele sollen über die üblicherweise betrachteten Settings hinausgehend verdeutlichen, wie verschieden die Inhalte und die Umsetzung von Interventionen zur Gesundheitsförderung sein können.

Globale gesundheitsfördernde Maßnahmen: Das Gesunde-Städte-Projekt

Eine weltweit angelegte Initiative ist das Modellprojekt „Healthy Cities" (Gesunde-Städte-Projekt), das 1986 im Zusammenhang mit der Ottawa-Charta gestartet wurde.

Dieses von der WHO initiierte Projekt ist ein langfristiges, international ausgerichtetes Projekt zur Gesundheitsförderung (Ashton et al., 1986). Sein Ziel besteht darin, weltweit die Gesundheit der Bevölkerung in Städten und Gemeinden in der politischen Tagesordnung zu verankern und eine Lobby für die Stärkung der öffentlichen Gesundheit aufzubauen, um einen Beitrag zur Verbesserung des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens von Menschen zu leisten. In Europa haben sich rund 100 Städte in 30 Ländern dieser Initiative angeschlossen, darunter in Deutschland zum Beispiel Hamburg, Berlin, Münster, Dortmund und Dresden (siehe https://gesunde-staedte-netzwerk.de/?id=2). Die Grundlegung und Vorgehensweise des Gesunde-Städte-Projekts zeigt Video 1.2.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Video 1.2. WHO: Making cities healthier – improving health for all (Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, WHO). Verfügbar unter https://youtu.be/cmSLlKLHjVo

Das Ziel der Verbesserung des körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens der Bewohner:innen einer Stadt erfordert den Einbezug aller Ebenen der Gesundheitsförderung (siehe Abbildung 1.3), von der Stadtregierung und -verwaltung bis hin zu den einzelnen Bewohner:innen. Die Veränderung von Entscheidungs- und Kommunikationsstrukturen ist für die Erreichung von Gesundheitsförderung und Gesundheitsgerechtigkeit ebenso wichtig wie die Kooperation aller beteiligten Institutionen und Agierenden in dem Prozess (World Health Organization, 1997). Es werden dabei im Allgemeinen elf Indikatoren für eine gesunde Stadt beschrieben:

- eine saubere, sichere und qualitativ hochwertig physische Umwelt (auch bezogen auf die Wohnumgebung),
- ein aktuell und in Zukunft stabiles und nachhaltiges Ökosystem,
- eine starke, unterstützende und nicht-ausbeutende Gemeinde,
- ein hohes Maß an Partizipation und Kontrolle der Öffentlichkeit bei denjenigen Entscheidungen, die ihr Leben, ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden betreffen,
- die Befriedigung von Grundbedürfnissen (nach Ernährung, Wasser, Schutz, Einkommen, Sicherheit) für alle Menschen einer Stadt,
- Zugang zu vielfältigen Erfahrungen, Ressourcen und Möglichkeiten zu Kontakt,
- eine gesunde, breit gefächerte und innovative wirtschaftliche Situation in der Stadt,
- die Ermutigung zur Besinnung und Nutzung der historischen, kulturellen und biologischen Wurzeln der Bewohner:innen einer Stadt,
- eine Gestaltung, die die bereits genannten Merkmale unterstützt oder zumindest mit ihnen vereinbar ist,
- eine für alle zugängliche optimale Gesundheitsversorgung,
- ein hohes Ausmaß an Gesundheit und ein geringes Vorkommen von Krankheit.

Die Förderung dieser Indikatoren erfolgt durch die Planung und Durchführung von Teilprojekten, die auf einzelne oder mehrere Ziele, Indikatoren oder Gruppen ausgerichtet sind und zur Verbesserung umschriebener gesundheitsbezogener Bereiche beitragen sollen.

In Taiwan wurde das Gesunde-Städte-Projekt ab 2002 in mehreren Modellstädten und -regionen implementiert. Die Stadt Tainan wurde 2003 als eine der ersten Modellstädte ausgewählt (Hu & Huang, 2020). Wesentliche Arbeitsschritte bei der Umsetzung des Projekts in Tainan waren:

- Die Bildung von effizienten Lenkungs-, Forschungs- und Arbeitsgruppen
- Identifizierung aussagekräftiger Indikatoren für die erfolgreiche Umsetzung der Gesunde-Städte-Ziele,
- Etablierung von Strukturen für kommunale Mitbestimmung und sektorenübergreifende Zusammenarbeit in Tainan,
- Auslobung von Wettbewerbspreisen für die Teilnahme von Institutionen aus anderen Bereichen als dem Gesundheitssektor,
- Bildung einer Allianz mit anderen Städten zur weiteren Förderung des Gesunde-Städte-Projekts.

Eine konkrete Initiative des Projekts war das "Arcade Unblocking Project". Dieses Projekt zielte auf die Verbesserung der Gestaltung von traditionellen überdachten Durchgängen und Fußgängerwegen, um eine barrierefreie Begehbarkeit, höhere Sicherheit und in der Konsequenz

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

neben einer gesteigerten Fußgänger:innen-Freundlichkeit auch eine Stärkung des lokalen Einzelhandels zu erreichen.

Bei einer umfassenden Evaluation des Gesunde-Städte-Projekts in Tainan kamen Lee et al. (2021) zu dem Ergebnis, dass das Projekt auch nach Abschluss erfolgreich in der Administration von Tainan institutionalisiert werden konnte. Park et al. (2021) weisen jedoch als Resultat einer Bewertung von Gesunde-Städte-Projekten in Korea darauf hin, dass unter anderem fehlende gesetzliche Rahmenbedingungen für die Realisierung einer gesunden Stadt die Abgrenzung von Gesunde-Städte-Projekten zu anderen Gesundheitsförderungsprojekten und damit auch eine eigenständige abschließende Evaluation erschweren.

Kasten 1.1. Inhalte des Gesunde-Städte-Projekts in Tainan (Taiwan).

Gesundheitsförderungsmaßnahmen in zielgruppenspezifischen Settings

Settings wurden oben als soziale Systeme charakterisiert, von denen bekannt ist oder angenommen wird, dass sie gesundheitsrelevant sind, und in denen gesundheitsfördernde Maßnahmen realisiert werden können. Die Implementierung settingbezogener Interventionen setzt jedoch die Kenntnis voraus, welche Settings für eine Zielgruppe tatsächlich relevant sind, um so speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittene Maßnahmen mit wirksamen Kommunikationsstrategien entwickeln zu können (Kreuter & Wray, 2003; siehe auch Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping“). Das Potential und die Voraussetzungen für die Nutzung von zielgruppenspezifischen Settings für gesundheitsfördernde Maßnahmen kann am Beispiel von Barbershops illustriert werden, die von afroamerikanischen Männern frequentiert werden.

Afroamerikanische Männer sind gesundheitlich benachteiligt, sowohl hinsichtlich einer niedrigen Lebensqualität als auch einer geringen Lebenserwartung (Shikany et al., 2018). Die Folgen gesundheitlicher Ungleichheit manifestieren sich bei ihnen unter anderem in überdurchschnittlich hohen Prävalenzraten chronischer Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes mellitus und kardiovaskulären Erkrankungen. Krebserkrankungen, und hier insbesondere Prostatakrebs, treten bei afroamerikanischen Männern ebenfalls deutlich häufiger als bei anderen amerikanischen Bevölkerungsgruppen auf. Auch gewaltbedingte Gesundheitsschäden und lebensstilbedingte Risikofaktoren wie Übergewicht tragen zu der hohen Mortalität und Morbidität afroamerikanischer Männer bei. Trotz dieser negativen gesundheitlichen Situation gibt es nur wenig klinische Studien und Interventionen, die auf diese Zielgruppe zugeschnitten sind, so dass sie auch in Bezug auf gesundheitsfördernde Maßnahmen unterrepräsentiert ist. Vor dem Hintergrund dieser ungünstigen Gesamtsituation weisen Wippold et al. (2023) auf die Notwendigkeit gender- und kultursensibler Interventionsangebote hin. Als besonders geeignete Settings für solche Interventionen identifizierten sie Barbershops aufgrund derer langen Tradition als kulturelle Institutionen und Orte des Austauschs für afroamerikanische Männer (siehe Kasten 1.2).

In einer Metaanalyse fassten Wippold et al. (2023) die Ergebnisse von zwölf Interventionsstudien zusammen, die die Wirksamkeit gesundheitsbezogener, in Barbershops implementierter Interventionen für afroamerikanische Männer untersuchten. Die Studien wurden sowohl in ländlichen als auch städtischen Gegenden unterschiedlicher amerikanischer Bundesstaaten durchgeführt. Die angezielten gesundheitsfördernden Maßnahmen bezogen sich auf Prostatakrebs-Screenings, Reduktion von Bluthochdruck, Vermeidung von HIV-Infektionen durch Kondomgebrauch und Gewaltprävention. Die Gestaltung und Vermittlung der Interventionen war sehr unterschiedlich; die Dauer und Häufigkeit reichten von einmaligen,

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

kurzen bis zu mehrmonatigen und -stündigen Angeboten, die entweder von den Barbershop-Mitarbeitenden oder von Externen (wie z. B. medizinischem Fachpersonal) vermittelt wurden. Die Ergebnisse der Metaanalyse zeigten, dass bei elf der untersuchten Interventionen Verhaltensveränderungen in die erwünschte Richtung (etwa Senkung des systolischen Blutdrucks oder Intention zur Teilnahme an einer Prostata-Früherkennungsuntersuchung) resultierten, was auf die positiven Effekte eines zielgruppensensiblen Settings für gesundheitsfördernde Maßnahmen bei afroamerikanischen Männern hinweist.

Kasten 1.2. Inhalt und Ergebnisse einer Metaanalyse zu gesundheitsfördernden Interventionen für afroamerikanische Männer im Setting Barbershop (Wippold et al., 2023).

Auch dieses zweite Beispiel verdeutlicht, wie wichtig eine genaue Analyse der Bedarfe und Bedürfnisse von Zielgruppen ist, für die gesundheitsfördernde Maßnahmen entwickelt werden sollen (siehe auch Kurs 2, Kapitel 4 „Intervention Mapping"). Bei jeder entsprechenden Intervention muss daher geprüft werden, in welchem Setting sie am wirkungsvollsten realisiert werden kann. Neben den bereits mehrfach erwähnten „klassischen" Settings (also etwa Kindertagesstätten, Betriebe, Gemeinden) gibt es, wie bei dem Gesunde-Städte-Projekt, auch solche, die aufgrund von geographischen Gegebenheiten geeignet sind oder andere, die sich zum Beispiel im Zuge informationstechnischer Entwicklungen als virtuelle Settings etabliert haben und entsprechend genutzt werden können.

1.3 Krankheitsprävention

„Vorbeugen ist besser als Heilen" oder „Vorsorge ist besser als Nachsorge" können als die Leitprinzipien der Krankheitsprävention aufgefasst werden. Der Begriff Prävention leitet sich vom lateinischen praevenire ab, das so viel wie „zuvorkommen", „verhindern" oder „vereiteln" bedeutet. Prävention umfasst alle Eingriffs- beziehungsweise Interventionshandlungen, die der Vermeidung des Eintretens, der Verschlimmerung oder des Ausbreitens von Krankheiten durch die Beeinflussung und/oder Reduktion von krankheitsspezifischen Risikofaktoren dienen. Eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung solcher gezielten, effektiven und evidenzbasierten Interventionen sind Kenntnisse zur Entwicklung des Krankheitsgeschehens beziehungsweise der pathogenetischen Dynamiken der jeweiligen Erkrankung, auf die die Präventionsmaßnahme abzielt (Leppin & Blunck, 2024).

Prävention zielt auch auf die Verhinderung akuter Erkrankungen und gesundheitlicher Beeinträchtigungen, zum Beispiel durch unfallpräventive Maßnahmen in Betrieben oder Impfkampagnen zur Verhinderung von Grippeepidemien ab. Viele präventive Maßnahmen werden aber speziell mit dem Ziel entwickelt, chronische Krankheiten zu verhindern oder eine Verschlechterung des Gesundheitszustands bei chronisch Kranken zu vermeiden. Wie bereits im Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie" von Kurs 1 angesprochen, dominieren chronische Erkrankungen seit mehreren Jahrzehnten das Krankheitsspektrum. Sie werden oft in Zusammenhang mit schädigenden Verhaltensweisen und veränderten Umweltbedingungen gebracht und herrschen vor allem in westlichen Industrienationen vor, werden aber mittlerweile auch in Ländern mit geringem und mittlerem Einkommen immer häufiger (Bengel et al., 2003).

Aus den Kennzeichen chronischer Krankheiten (siehe Kurs 1, Kapitel 1 „Einführung in die Gesundheitspsychologie") lässt sich erschließen, dass sich diejenigen, die unter einer chronischen Erkrankung leiden, mit einer Vielzahl von krankheitsbedingten Anforderungen auseinandersetzen müssen. Die Verarbeitung der Diagnosestellung, der Umgang mit den Symptomen und den täglichen Behandlungsvorschriften, die Anpassung oder auch Umstellung des Lebensrhythmus an

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

die Erfordernisse der Krankheit sowie die Integration der Erkrankung in das eigene Selbstkonzept sind Aufgaben, die chronisch kranke Menschen bewältigen müssen, um ihr Leben im Einklang mit ihrer Krankheit führen zu können. Gelingt chronisch kranken Menschen diese Bewältigung nicht, dann können daraus ein schlechter körperlicher Zustand aufgrund von vernachlässigten Behandlungsvorschriften oder negative psychische Folgeerscheinungen wie Angst und depressive Erkrankungen resultieren (Krämer & Bengel, 2016; siehe auch Kurs 2, Kapitel 7 „Patientenschulungen"). Neben der Verhinderung individueller Beeinträchtigungen durch die Entstehung oder Verschlechterung einer Krankheit ist die Prävention chronischer Krankheiten auch aufgrund der hohen Kosten, die diese für das Gesundheitssystem verursachen, ein wichtiges Anliegen.

1.3.1 Unterscheidungsmerkmale von Präventionsmaßnahmen

Je nach Eingriffszeitpunkt, Zielgruppe, Spezifität und generellen Wirkrichtungen von Maßnahmen lassen sich verschiedene Präventionsformen unterscheiden.

Primäre, sekundäre und tertiäre Prävention

Tabelle 1.2 veranschaulicht die zeitlichen Ansatzpunkte von Präventionsmaßnahmen und stellt sie der Gesundheitsförderung gegenüber.

Als *primäre Prävention* werden alle Maßnahmen bezeichnet, die vor dem ersten Auftreten einer Krankheit durchgeführt werden, um das Ausbrechen der Krankheit zu verhindern (Leppin & Blunck, 2024). Das Ziel ist dabei die Verringerung von Neuerkrankungen. Typische Inhalte der primären Prävention sind die Aufklärung über gesundheitlich beeinträchtigende Verhaltensweisen oder Risikofaktoren (z. B. Rauchen, ungeschützter Geschlechtsverkehr, Drogenmissbrauch) beziehungsweise das Aufzeigen von Möglichkeiten zum Erhalt der Gesundheit (z. B. Stressbewältigung; siehe auch Präventionsprinzipien im Leitfaden Prävention des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen, GKV-Spitzenverband, 2014), noch bevor spezifische Risikofaktoren oder die Erkrankung identifizierbar sind. (Massen-)Impfungen werden üblicherweise ebenfalls der primären Prävention zugeordnet. Dies sind zum Beispiel die im Rahmen der empfohlenen Vorsorgeuntersuchungen für Kinder (U1-9) durchgeführten Impfungen sowie die alljährlichen bevölkerungsübergreifenden Grippe-Impfungen vor allem für Risikogruppen wie ältere und chronisch kranke Menschen. Impfungen werden nicht nur wegen des individuellen Nutzens, sondern auch als ein Instrument der bevölkerungsweiten Absicherung gegen Infektionskrankheiten empfohlen. Hierfür wurde der Begriff der Herdenimmunität geprägt. Dieses Konzept beschreibt den Effekt, dass in einer Gruppe, in der ausreichend Personen gegen einen Krankheitserreger aufgrund von Impfung oder einer vorherigen Infektion immun sind, auch nicht-immune Menschen vor einer Infektion geschützt sind, da die durch den Erreger ausgelöste Erkrankung nicht auftritt (Betsch et al., 2017; Robert Koch-Institut, 2015). Unter dem Link https://www.impfen-info.de/wissenswertes/gemeinschaftsschutz/ wird das Prinzip des Gemeinschaftsschutzes (Herdenimmunität) am Beispiel der Masern durch eine Animation erklärt.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Tabelle 1.2

Phasen der gesundheitsbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung. Nach Techniker Krankenkasse, 2020, S. 11.

Phase	Primärprävention (nicht medizinisch)	Sekundär-prävention	Tertiärprävention	Gesundheits-förderung
Zeitpunkt der Intervention	Vor Erstauftreten einer Erkrankung	In Frühstadien einer Krankheit	Nach Manifestation einer Krankheit, vielfach schon chronische Erkrankungen	Richtet sich an alle Menschen in allen Lebenslagen
Ziel	Verminderung von Risikofaktoren, Ausschalten gesundheits-schädigender Faktoren, Risikoschutz, Sicherheitserhöhung	Frühzeitige Diagnose, oder Ausschluss von Krankheiten durch Vorsorge- und Früherkennungs-untersuchungen	Verhinderung oder Verlangsamung von Krankheitsverschlech-terung, Vermeidung von Folgeschäden, Folgeerkrankungen und Rückfällen, Vermeidung der Ausgliederung aus Arbeit, Beruf, Gesellschaft	Verbesserung gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen, Lebens- und Arbeitsbedingungen durch Stärkung der Ressourcen, Stärkung von Schutzfaktoren, Aufbau von Lebenskompetenz
Zielgruppen	Personen ohne manifeste physiologische oder psychologische Beeinträchtigungen, die ggf. an der Schwelle zu einer Erkrankung stehen	Personen, die (z. B. altersgemäß, genetisch bedingt) einer bestimmten Risikogruppe angehören, oder bereits manifeste Symptome aufweisen	Personen, die von einer manifesten Krankheit betroffen sind und behandelt werden, Patient:innen mit chronischen Beeinträchtigungen	Unabhängig vom Gesundheitszustand; auf der Ebene des Individuums, der Organisation/der Lebenswelt (Setting-Ansatz) bzw. der Gesamtbevölkerung
Leistungen gesetzlicher Kranken-versicher-ungen im Rahmen des SGB V	§20 Prävention und Selbsthilfe, §20a Betriebliche Gesundheits-förderung, §20b Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, §20d Schutzimpfungen, §21 und §22 Verhütung von Zahnerkrankungen	§20c Förderung der Selbsthilfe, §23 und §24 Medizinische Vorsorgeleistungen, §25 Gesundheits-untersuchungen	§20c Förderung und Selbsthilfe	§20a Betriebliche Gesundheits-förderung, im Leitfaden der gesetzlichen Krankenkassen erweitert um den Setting-Ansatz
Beispiele	medizinische Primärprävention: Schutzimpfungen nicht medizinische Primärprävention: Minimierung von Alkohol-/ Tabakmissbrauch, Ernährung und Bewegungsförderung, Allergiemanagement, Stressbewältigung	Früherkennungs-untersuchungen auf Gebärmutterhals-, Haut- und Darmkrebs, arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-suchungen (Erkennen/Minimieren von psychischen Belastungen im Setting), Neugeborenen-Screening	Kur- und Heilbehandlungen, Palliativpflege, betriebliche Wiedereingliederung (Case Management), Netzwerk psychische Gesundheit, Selbst-hilfegruppen, soziale und berufliche Rehabilitation	Gesundheitstage, psychosoziale Beratung, betriebliche Gesundheitsförderung als Organisations-entwicklung, Arbeitskreis Gesundheitsfördernde Hochschulen

Anmerkung. SGB V = Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch.

Als *sekundäre Prävention* werden Maßnahmen bezeichnet, die der Früherkennung und damit der Möglichkeit einer rechtzeitigen Behandlung von Erkrankungen dienen (Leppin & Blunck, 2024). Ziel ist die Senkung von Prävalenzraten, also die Verringerung des Auftretens bestimmter Krankheiten. Somit sollen eine Verschlimmerung oder Unheilbarkeit der Krankheit aufgrund eines zu späten Behandlungsbeginns verhindert werden. Typische Bestandteile der sekundären

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Prävention sind Screening- oder Vorsorgeuntersuchungen, die eine Aufdeckung symptomloser Erkrankungen bei scheinbar gesunden Menschen ermöglichen sollen. Konkrete Beispiele umfassen Check-up-Untersuchungen und Screenings, insbesondere zu Krebserkrankungen, wie den Papanicolaou-Test (Pap-Test) zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs oder die Darmspiegelung zur Früherkennung von Darmkrebs. Einen Überblick über Früherkennungsuntersuchungen gibt die Webseite des Gemeinsamen Bundesausschusses unter dem Link: https://www.g-ba.de/themen/methodenbewertung/frueherkennungsuntersuchungen/.

Die *tertiäre Prävention* fällt in den Bereich der Rehabilitation und der kurativen Medizin. Sie umfasst Maßnahmen, die der Verhinderung des Fortschreitens oder des Auftretens von Komplikationen bei einer bereits manifesten Erkrankung dienen (Leppin & Blunck, 2024). Ziel ist es, eine Verschlechterung des Zustandes, Folgeerkrankungen und Rückfälle zu verhindern sowie damit verbundene Krankheitsfolgen (v. a. chronische Verläufe) abzumildern. Typische Beispiele der tertiären Prävention sind Rehabilitationsmaßnahmen bei chronischen Schmerzen und Anschlussheilbehandlungen nach einem Herzinfarkt.

Als eine Erweiterung der von Caplan (1964) vorgeschlagenen zeitlich orientierten Kategorisierung von Präventionsmaßnahmen in primäre, sekundäre und tertiäre Prävention wurde zusätzlich die Klassifizierung *quartäre Prävention* vorgeschlagen, um dem Phänomen unnötiger medizinischer Eingriffe und Maßnahmen insbesondere bei älteren und komorbid chronisch erkrankten Menschen Rechnung zu tragen (Jamoulle, 2015). Hierfür wird zwischen den Begriffen *illness* (subjektiver Zustand fehlenden Wohlbefindens) und *disease* (medizinisch diagnostizierbare Krankheit) unterschieden. Liegt ein subjektives Leiden (illness) vor, das jedoch nicht als behandlungsbedürftige Krankheit (disease) diagnostiziert werden kann, sollte die Notwendigkeit und vor allem die Nützlichkeit medizinischer Eingriffe oder Maßnahmen gemeinsam mit dem/der Patient:in genau abgewogen werden (Kühlein et al., 2018).

Präventionsmaßnahmen nach Zielgruppen und Spezifität

Neben dem Interventionszeitpunkt lassen sich Präventionsmaßnahmen danach unterscheiden, ob sie universell wirken sollen oder für bestimmte Zielgruppen entwickelt werden.

Universelle Präventionsmaßnahmen zielen darauf ab, bevölkerungsweit präventiv zu wirken. Es erfolgt somit keine Auswahl der Adressaten aufgrund spezifischer Kriterien und ist damit vorrangig im Bereich der primären Prävention zu verorten. Beispiele hierfür wären Standardimpfungen wie gegen Masern, Mumps und Röteln, sowie Jugendschutzgesetze, die den Verkauf von Alkohol und Tabak an Minderjährige untersagen (Leppin & Blunck, 2024).

Mit *zielgruppenspezifischen Präventionsmaßnahmen* werden hingegen bestimmte Gruppen der Bevölkerung angesprochen, die aufgrund ihrer Lebenssituation oder Vorerkrankungen überdurchschnittlich ausgeprägte oder spezifische Risikofaktoren in Hinblick auf spezifische Krankheiten aufweisen (Leppin & Blunck, 2024). Unterschieden wird hier zwischen *selektiven* und *indizierten Präventionsmaßnahmen*. Selektive Präventionsstrategien beziehen sich auf Personen, die zwar aufgrund bestimmter Merkmale ein erhöhtes Erkrankungsrisiko aufweisen, jedoch noch nicht erkrankt sind – beispielsweise das Darmkrebsscreening für Personen ab 50 Jahren. Indizierte Präventionsstrategien hingegen zielen auf Personen ab, die bereits Vorstufen einer Erkrankung aufweisen, um so beispielsweise bei Menschen mit hohem Blutdruck mainfeste Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verhindern (Leppin & Blunck, 2024).

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Verhaltens- und Verhältnisprävention

Weiterhin lassen sich Präventionsmaßnahmen hinsichtlich ihrer generellen Umsetzungsstrategien und Ansatzpunkte in Verhaltensprävention und Verhältnisprävention unterscheiden (Dadaczynski & Pulus, 2018).

Verhaltensprävention umfasst Maßnahmen, die eine Krankheitsvermeidung durch die Veränderung des Verhaltens von Personen erreichen sollen. Ziel ist demnach die Einflussnahme auf individuelles Verhalten, sei es auf direktes (Risiko-)Verhalten wie Rauchen und Bewegungsmangel oder indirektes Gesundheitsverhalten wie die Inanspruchnahme medizinisch-technologischer Interventionen (z. B. Impfungen, Früherkennungsuntersuchungen).

Verhältnisprävention beschreibt die Vermeidung von Krankheiten durch eine Veränderung der Lebensverhältnisse beziehungsweise strukturelle Veränderungen der Lebenswelten von Personen. Ziel ist es, eine Lebensumwelt zu schaffen, die direkt (z. B. durch Rauchverbote in öffentlichen Räumen) oder indirekt durch die Anregung von Gesundheitsverhalten infolge externer Anreize (z. B. Vorsorgeangebote im Betrieb, Bonusheft bei zahnärztlichen Behandlungen) krankheitsvermeidend wirkt. Video 1.3 illustriert verhältnispräventive Maßnahmen im Setting Schule (siehe auch Kurs 3, Kapitel 1 „Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen/Setting Schule“).

Video 1.3. Präventionsinitiative fit4future – Modul Verhältnisprävention (DAK Gesundheit). Verfügbar unter https://youtu.be/s0pLfoRw3wY

1.3.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen der Prävention in Deutschland

Steigende Fallzahlen vor allem bei chronischen Krankheiten erfordern vom Gesundheitswesen die langfristige Bereitstellung umfangreicher Ressourcen bei zugleich strukturell bedingten, fortbestehenden Mängeln und Barrieren in der Versorgungssituation (Brinkmann-Göbel, 2001; Rosenbrock & Kümpers, 2006). Die für die Krankheitsprävention wichtigen gesetzlichen Grundlagen finden sich vor allem im Sozialgesetzbuch (SGB).

Das deutsche Sozialversicherungsmodell – historische Entwicklung

Das Sozialversicherungsmodell in Deutschland geht auf die Einführung einer Krankenversicherung durch den damaligen Reichskanzler Otto von Bismarck zurück. Das sogenannte *Bismarck-Modell* wurde am 15. Juni 1883 eingeführt und bildete den Grundstein der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) in Deutschland. Der Großteil der sozialen Absicherung in Deutschland wird durch die fünf gesetzlichen Sozialversicherungen abgedeckt, bestehend aus der GKV (seit 1883), der gesetzlichen Unfallversicherung (seit 1884), der gesetzlichen Rentenversicherung (seit 1889), der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung (seit 1927) und der gesetzlichen Pflegeversicherung (seit 1995). Ihr gemeinsames Kernelement stellt das Versicherungsprinzip dar. In der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung besteht kein Äquivalenzprinzip, also keine Entsprechung von Beitragshöhe und Leistungsansprüchen. So erfolgt die Erhebung der zu entrichtenden Beiträge an die Sozialversicherung nach Maßgabe der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (v. a. auf Grundlage des Gehalts), während die Leistungen (z. B. Behandlungskosten) bedarfsgerecht gewährt werden (Bundeszentrale für politische Bildung, 2017). In Deutschland sind gegenwärtig rund 88 % der Bürger:innen (ca. 73 Millionen Menschen) Mitglied in einer Gesetzlichen Krankenversicherung (Bundesministerium für Gesundheit, 2021; BMG)

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Das Präventionsgesetz

Das Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention (Präventionsgesetz – PrävG, §20 SGB V) wurde am 10. Juli 2015 im Bundesrat beschlossen und trat in seinen wesentlichen Teilen am 25. Juli 2015 in Kraft (Bundesministerium für Gesundheit, 2019). Die wesentlichen Inhalte beziehungsweise Handlungsfelder des Präventionsgesetzes umfassen vor allem die Prävention von sehr häufigen und kostenintensiven chronischen somatischen Krankheiten und psychischen Störungen, von Risikoverhaltensweisen (z. B. Alkohol- und Nikotinkonsum) sowie die Förderung von Gesundheitskompetenzen über die Lebensspanne als Voraussetzung für die „Hilfe zur Selbsthilfe". Beide Strategien, Prävention und Gesundheitsförderung, wurden zu Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen erklärt und werden daher von ihnen mitfinanziert. Unter Einbezug aller gesetzlichen und privaten Sozialversicherungsträger sowie unter Berücksichtigung vorhandener Strukturen soll die Gesundheit insbesondere in den Lebenswelten von Menschen gestärkt werden (siehe Abschnitt 1.2 „Gesundheitsförderung"). Weiterhin sollen Angebote zur Krankheitsfrüherkennung weiterentwickelt und Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Arbeitsschutzes besser aufeinander abgestimmt werden.

Die Schwerpunkte des Präventionsgesetzes beziehen sich auf folgende Themen (Bundesministerium für Gesundheit, 2019):

- Typ-2-Diabetes mellitus: Erkrankungsrisiko senken, an Typ-2-Diabetes mellitus Erkrankte frühzeitig erkennen und die Erkrankung behandeln (siehe auch Kurs 2, Kapitel 7 „Patientenschulungen"),
- Brustkrebs: Sterblichkeit vermindern und Lebensqualität erhöhen,
- Tabakkonsum reduzieren,
- Gesund aufwachsen: Lebenskompetenz, Bewegung, Ernährung,
- Gesundheitliche Kompetenz erhöhen, Souveränität der Patient:innen stärken,
- Depressive Erkrankungen verhindern, früh erkennen, nachhaltig behandeln,
- Gesund älter werden,
- Alkoholkonsum reduzieren.

1.3.3 Kosten und Wirksamkeit präventiver Maßnahmen

Die ökonomische Bewertung präventiver Maßnahmen kann auf Basis vergleichender oder nicht vergleichender Analysen erfolgen: *Nicht vergleichende Analysen* stellen eine rein deskriptive Analyse der Präventions- oder Krankheitskosten dar, während *vergleichende Analysen* die gesundheitlichen Auswirkungen von Interventionen zu den eingesetzten Kosten in Relation setzen (z. B. Kosten-Nutzen-, Kosten-Wirksamkeits-/Effektivitäts-Analysen; Plamper et al., 2024; siehe auch Kurs 2, Kapitel 5 „Evaluation gesundheitspsychologischer Maßnahmen"). Bei vergleichenden Analysen werden also *Wirksamkeit*, *Qualität* und *Wirtschaftlichkeit* der präventiven Maßnahmen berücksichtigt (Plamper et al., 2024).

Hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit einer Präventionsmaßnahme kann innerhalb des Gesundheitssektors zwischen direkten, indirekten und intangiblen Kosten unterschieden werden(Plamper et al., 2024): *Direkte Kosten* sind unmittelbar durch die Krankheit selbst entstehende Kosten (z. B. Behandlungskosten und Medikamente). *Indirekte Kosten* entstehen außerhalb des medizinischen Sektors durch einen krankheitsbedingten Produktivitätsverlust (z. B. Verlust oder Einschränkung der Arbeitskraft). *Intangible Kosten* beziehen sich auf negative psychosoziale Folgen, die durch die Krankheit verursacht werden (z. B. Verlust an Lebensqualität, Schmerzen, Depression). Außerhalb des Gesundheitssektors kommen außerdem noch *externe*

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

Kosten hinzu, die zum Beispiel Kosten im Bildungssektor oder in der sozialen Sicherheit berücksichtigen. Ein Beispiel für eine entsprechende Präventionsmaßnahme wäre die „Kenn dein Limit"-Kampagne des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit in Kooperation mit dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (https://www.kenn-dein-limit.de/). Die Kampagne zielt auf einen bewussten Umgang mit oder den Verzicht auf Alkohol ab und trägt somit neben der Reduktion medizinischer Probleme auch zur Erhöhung erfolgreicher Schul- und Berufsabschlüsse und zur Vermeidung rauschbedingten sozialen Fehlverhaltens bei (Plamper et al., 2024).

Diverse Übersichtsarbeiten zur Kosten-Effektivitäts-Analyse von Präventionsmaßnahmen lieferten vielversprechende Ergebnisse: Programme zur Prävention von psychischen Störungen und zur Förderung der psychischen Gesundheit zeigten über verschiedene Altersgruppen hinweg (Kinder, Jugendliche und Erwachsene) eine positive Bilanz für Kosten und Wirksamkeit (Le et al., 2021). Auch zielgruppenspezifische Programme zur Diabetesprävention wiesen eine gute Kosten-Effektivität auf, wobei diese in Abhängigkeit der Interventionsqualität variierte (Zhou et al., 2020). Le et al. (2021) wiesen einschränkend darauf hin, dass die Generalisierung der Ergebnisse unter anderem aufgrund der vorrangigen Untersuchung in Ländern mit hohem Einkommen und aufgrund unterschiedlicher Evaluationsmethoden eingeschränkt ist.

Bei der Evaluation gesundheitsfördernder und präventiver Maßnahmen sind einige praktische Einschränkungen zu bedenken: Zum einen werden in der Praxis oftmals verschiedene Maßnahmen kombiniert, so dass keine eindeutigen Aussagen zur Effektivität einzelner Maßnahmen erfolgen können. Zum anderen treten die Effekte teilweise mit einer großen zeitlichen Verzögerung ein, so zum Beispiel eine längere Lebensdauer und die Verminderung von Erblindung oder Dialyse im hohen Alter bei Menschen mit Diabetes mellitus. Ein empirischer Nachweis der Wirksamkeit würde also viele Jahre in Anspruch nehmen. Bei der Evaluation primärpräventiver Maßnahmen ergeben sich außerdem gerade für den Bereich der Verhältnisprävention einige Unsicherheiten bei der Auswahl und Umsetzung von geeigneten Vorgehensweisen (z. B. bezüglich der Operationalisierung von Outcome-Maßen oder valider Messinstrumente), wodurch es momentan an einer empirischen Fundierung verhältnispräventiver Interventionen in Deutschland mangelt (Robert Koch-Institut, 2015).

1.3.4 Präventionsprogramme in der Anwendung

Um die Umsetzung von Präventionsprogrammen in unterschiedlichen Settings zu demonstrieren, werden zwei Interventionen vorgestellt: Das Lübecker Projekt Bewegungswelten für pflegebedürftige Menschen sowie ein Programm zur Prävention kindlicher Verhaltensstörungen durch ein Elterntraining.

Prävention von Funktionseinbußen bei Pflegebedürftigen

Das „Lübecker Modell Bewegungswelten" (LMB) wurde von der Forschungsgruppe Geriatrie Lübeck (https://www.forschungsgruppe-geriatrie-luebeck.de/) als präventives gesundheitsförderliches Programm für pflegebedürftige ältere Menschen in stationären Einrichtungen entwickelt. Allgemeine Ziele sind die Vorbeugung des Fortschreitens bereits vorhandener Funktionseinbußen und der damit einhergehenden zunehmenden Pflegebedürftigkeit. Gleichermaßen sollen die noch vorhandenen geistigen, körperlichen und kommunikativ-sozialen Fähigkeiten gestärkte und erweitert werden, um eine möglichst hohe Selbstständigkeit auch in der stationären Pflegesituation zu ermöglichen (Ralf et al., 2019). Das Programm ist als standardisiertes Gruppentraining konzipiert und findet zweimal wöchentlich jeweils einstündig statt. Je nach motorischen und kognitiven Fähigkeiten der Teilnehmenden

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

bestehen die Gruppen aus sechs bis zwölf Personen, die von geschulten LMB-Trainer:innen angeleitet werden. Das Training in der Gruppe wird flankiert durch Anleitungen und Motivationshilfen für individuell durchzuführende Übungen, die die Teilnehmenden möglichst täglich trainieren sollen.

Ein wesentliches Gestaltungselement des Programms sind die namensgebenden Bewegungswelten. In jeder Trainingsstunde werden die Teilnehmenden angeleitet, eine alltagsbezogene „Bewegungswelt" (z. B. Garten, Strand, Hausarbeit) zu imaginieren. In der Sitzung werden alle Übungen zur Stärkung der Beweglichkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer so gestaltet, dass sie sich an Bewegungen orientieren, die typisch für die jeweilige Bewegungswelt sind (etwa Äpfel pflücken, Astschütteln oder das Hochsteigen einer Leiter in der Bewegungswelt „Garten"). Gleichzeitig sollen durch die gedankliche Beschäftigung mit einer Bewegungswelt kognitive Prozesse wie die Aktivierung von Gedächtnisinhalten aktiviert sowie der Austausch zwischen den Teilnehmenden stimuliert werden. Video 1.4 gibt einen Einblick in die Konzeption und Umsetzung des LMB.

Video 1.4. Lübecker Modell Bewegungswelten. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=GyVA0p6PzGE

Krupp et al. (2019) führten eine längsschnittliche Studie mit fünf Messzeitpunkten (Start, drei, sechs, neun und zwölf Monate) zur Evaluation von LMB durch, an der initial 225 Personen (171 in der Interventionsgruppe, 84 in der Kontrollgruppe) teilnahmen. Zu jedem Messzeitpunkt wurden Indikatoren der Funktionsbereiche Selbsthilfefähigkeit, Mobilität, Koordination, Beweglichkeit, Kraft, Ausdauer und Kognition erhoben. Von den Teilnehmenden der Interventionsgruppe besuchten 75 Personen über den gesamten Studienverlauf mindestens 50 % der Trainingsstunden. Bei ihnen zeigten sich über den Verlauf der Studie im Vergleich zur Kontrollgruppe positive Effekte für die Bereiche Selbstständigkeit, Mobilität, Koordination und Kraft. Horn et al. (2019)unterstrichen außerdem die hohe und zeitüberdauernde Akzeptanz des LMB durch die Teilnehmenden.

Prävention kindlicher Verhaltensstörungen durch ein Elterntraining

Inhalt dieses Projekts ist die langfristige Wirkung eines Elterntrainings, das bei den Eltern von Kindergartenkindern durchgeführt wurde. Das Elterntraining *Triple P* (engl.: „Positive Parenting Program"; Sanders, 1999) zielt auf verschiedene Bereiche elterlichen Verhaltens, in denen die Programmteilnehmer:innen neue und verbesserte Fertigkeiten und Fähigkeiten im Umgang mit ihren Kindern erlernen sollen (siehe Kasten 1.3). In Video 1.5 werden die wesentlichen Elemente des Triple-P-Trainings zusammenfassend vorgestellt.

- Fähigkeit zur genauen Beobachtung des kindlichen und eigenen Verhaltens
- Ausüben von Verhalten, mit dem die Eltern-Kind-Beziehung positiv beeinflusst wird (z. B. mit dem Kind sprechen)
- Erwerb neuer Verhaltensmöglichkeiten (z. B. Setzen positiver Beispiele durch eigenes elterliches Verhalten)
- Umgang mit Problemverhalten (z. B. Setzen und Einhalten von Regeln)
- Verhinderung von Problemverhalten in riskanten Situationen (z. B. Aufstellen und Diskutieren von Verhaltensregeln für riskante Situationen, etwa im Straßenverkehr)
- Unterstützung von selbstregulativem Verhalten (z. B. durch die Gegenüberstellung von Stärken und entwicklungsbedürftigen Verhaltensbereichen)

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

- Gefühlsregulation und Bewältigungsverhalten (z. B. Erlernen von Entspannung)
- Stärkung der Unterstützung durch die Partner:innen und Erwerb von Kommunikationstechniken (z. B. Geben und Akzeptieren von konstruktivem partnerschaftlichem Feedback)

Kasten 1.3. Angezielte Verhaltensbereiche des Triple-P-Elterntrainings.

Video 1.5. Online-Programm für Eltern (Triple P – Positive Parenting Program). Verfügbar unter https://youtu.be/6OWoyHOktE0 (bzw. https://www.triplep.de)

Das Triple-P-Training wurde bereits in vielen verschiedenen Ländern und kulturellen Kontexten auf seine Wirksamkeit hin überprüft. Sanders et al. (2014) untersuchten im Rahmen einer Meta-Analyse die Wirksamkeit des Trainings in über 100 Studien. Bei den Kindern konnten hierbei positive Auswirkungen auf sozialer, emotionaler und behavioraler Ebene festgestellt werden. Für die Eltern zeigten sich eine erhöhte Zufriedenheit, eine verbesserte wahrgenommene Wirksamkeit bei der Erziehung und positive Effekte auf die Paarbeziehung. Auch hinsichtlich langfristiger Effekte kann das Training empirisch bestehen: In einem 10-Jahres-Follow-Up zeigten sich Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe hinsichtlich der Wirksamkeit des Trainings als universelle Maßnahme zur Prävention kindlicher Verhaltensauffälligkeiten (Hahlweg & Schulz, 2018). Weitere Effekte zeigten sich beispielsweise bei der Reduzierung von Kindesmisshandlung(Sanders et al., 2025), von Verhaltensauffälligkeiten bei Entwicklungsstörungen (Skotarczak & Lee, 2015) und bei der Prävention von Mobbingtäterschaft im Jugendalter, wenn das Training während der KiTa Zeit stattfand (Kim et al., 2021).

Unterscheidungsmerkmale von Präventionsprogrammen in der Anwendung

Anhand dieser beiden exemplarisch vorgestellten Präventionsprogramme lässt sich demonstrieren, dass die oben angeführten Unterscheidungsmerkmale von Präventionsprogrammen (primär, sekundär, tertiär; universell, zielgruppenspezifisch, selektiv, indiziert; verhaltens- oder verhältnisbezogen) bei der Anwendung von konkreten Präventionsprogrammen nicht immer eindeutig zu benennen sind. So ist bei beiden Programmen ein primärpräventives Anliegen ersichtlich (Vorbeugung von Funktionsverlust bzw. Verhaltensstörungen). Ein Elterntraining kann aber auch dabei helfen, erste Verhaltensdefizite bei Kindern frühzeitig zu erkennen und adäquate Maßnahmen einzuleiten, um eine Pathologisierung dieser zu vermeiden – dies wären Elemente einer Sekundärprävention. Das Verhindern des Fortschreitens bereits bestehender Pflegebedürftigkeit könnte hingegen auch als Tertiärprävention verstanden werden. Je nach Lagerung des Einzelfalls stehen demnach unterschiedliche Präventionsziele im Vordergrund. Die teilweise schwierige Zuordnung eines Programms in Bezug auf die Zielgruppe wird insbesondere durch das Triple-P-Elterntraining verdeutlicht. So kann das Programm z. B. als universelle Maßnahme zur Prävention kindlicher Verhaltensauffälligkeiten (Hahlweg & Schulz, 2018), oder auch als zielgruppenspezifische Maßnahme zur Reduktion von Verhaltensauffälligkeiten bei bestehender Entwicklungsstörung (Skotarczak & Lee, 2015) durchgeführt/verstanden werden. Es ist ebenfalls nicht ganz klar zu trennen, inwieweit es sich dabei ausschließlich um ein verhaltenspräventives Programm handelt. Das Programm ist zunächst explizit auf das elterliche Verhalten und seine Veränderung ausgerichtet; da sich aber im positiven Fall die nicht-materielle Umwelt des Kindes durch das verbesserte Erziehungsverhalten ändert, wäre es ebenso gerechtfertigt, eine verhältnispräventive Wirkung anzunehmen.

Die Unterscheidungsmerkmale und -ebenen präventiver Maßnahmen sind ausgesprochen hilfreich bei der Beschreibung und Abgrenzung konkreter Programme und Interventionen. In

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440

jedem Einzelfall muss dann geprüft werden, durch welche Charakteristika ein Programm besonders zutreffend beschrieben wird.

Literaturverzeichnis

Altgeld, T. (2024). Konzepte und Strategien der Gesundheitsförderung. In K. Hurrelmann, M. Richter & S. Stock (Hrsg.), *Referenzwerk Prävention und Gesundheitsförderung. Grundlagen, Konzepte und Umsetzungsstrategien* (6. Aufl., S. 55–73).

Antonovsky, A. (1979). *Health, stess, and coping: New perspectives on mental and physical well-being.* Jossey-Bass.

Antonovsky, A. (1987). *Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well*. Jossey-Bass.

Ashton, J., Grey, P. & Barnard, K. (1986). Healthy Cities: WHO's new public health initiative. *Health Promotion International*, *1*(3), 319–324. https://doi.org/10.1093/heapro/1.3.319

Becker, P. (1997). Prävention und Gesundheitsförderung. In R. Schwarzer (Hrsg.), *Gesundheitspsychologie: Ein Lehrbuch* (S. 517–534). Hogrefe.

Becker, P. (2006). *Gesundheit durch Bedürfnisbefriedigung*. Hogrefe.

Bengel, J., Beutel, M., Broda, M., Haag, G., Härter, M., Lucius-Hoene, G., Muthny, F. A., Potreck-Rose, F., Stegie, R. & Weis, J. (2003). Chronische Erkrankungen, psychische Belastungen und Krankheitsbewältigung: Herausforderungen für eine psychosoziale Versorgung in der Medizin. *Psychotherapie, Psychosomatik, Medizinische Psychologie*, *53*(2), 83–93. https://doi.org/10.1055/s-2003-36964

Betsch, C., Böhm, R., Korn, L. & Holtmann, C. (2017). On the benefits of explaining herd immunity in vaccine advocacy. *Nature Human Behaviour*, *1*(3). https://doi.org/10.1038/s41562-017-0056

Blümel, S. (2024). Systemisches Anforderungs-Ressourcen-Modell in der Gesundheitsförderung. In Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (Hrsg.), *Leitbegriffe der Gesundheitsförderung und Prävention. Glossar zu Konzepten, Strategien und Methoden.*

Brinkmann-Göbel, R. (2001). Gesundheitsberatung: Zur Relevanz eines "neuen" Elements im Gesundheitswesen. In R. Brinkmann-Göbel (Hrsg.), *Handbuch für Gesundheitsberater* (S. 13–32). Huber.

Bundesministerium für Gesundheit. (2019). *Präventionsgesetz*. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/begriffe-von-a-z/p/praeventionsgesetz/

Bundesministerium für Gesundheit. (2021). *Geschichte der gesetzlichen Krankenversicherung*. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/grundprinzipien/geschichte.html

Bundeszentrale für politische Bildung. (2017). *Die gesetzliche Krankenversicherung im System der sozialen Sicherung*. https://www.bpb.de/themen/gesundheit/gesundheitspolitik/252394/die-gesetzliche-krankenversicherung-im-system-der-sozialen-sicherung/

Caplan, G. (1964). *Principles of preventive psychiatry*. Basic Books.

Dadaczynski, K. (2022). Prävention und Gesundheitsförderung in Settings und Lebenswelten. In R. Haring (Hrsg.), *Gesundheitswissenschaften* (S. 445–454). Springer.

Dadaczynski, K. & Pulus, P. (2018). Verhaltens- und Verhältnisprävention. In C. W. Kohlmann, M. Wirtz & C. Salewski (Hrsg.), *Psychologie in der Gesundheitsförderung* (S. 257–268). Hogrefe.

Urheberrechtlich geschützt. Persönliche Kopie für Matrikelnummer 4514440